ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА В ИЗЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Жёлтая лихорадка

Трансмиссивная арбовирусная инфекция: эндемичные страны, двухфазное течение, «амарильная маска» и эпидемиологический анамнез

Источник: информационное письмо ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/820 от 04.03.2024.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 11 октября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

О чём письмо

Письмо издано по информации Управления Роспотребнадзора по Москве, полученной из Федеральной службы от 12.02.2024 № 02/2306-2024-32 «О профилактике жёлтой лихорадки».

Операционное правило: **при вызове к пациенту с лихорадкой до 40 °C, мышечной болью, желтушностью склер, головной болью и тошнотой или рвотой уточняется пребывание в эндемичных по жёлтой лихорадке странах; при подозрении действует приказ Станции № 2710 от 10.11.2023.**

Жёлтая лихорадка как болезнь

Жёлтая лихорадка — острое зооантропонозное природно-очаговое инфекционное трансмиссивное заболевание, передаваемое комарами; характеризуется двухфазным течением, лихорадкой, желтухой, геморрагическим синдромом и поражением сосудов, печени и почек. Возбудитель — РНК-содержащий арбовирус.

Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей (передаётся комарами от заражённых обезьян) и лихорадка населённых пунктов (комар передаёт вирус от человека к человеку); вторая форма вызывает большинство вспышек и эпидемий. Переносчики в городских очагах — комары *Aedes aegypti*, в джунглях — отдельные виды лесных комаров; в инфицированном комаре вирус сохраняется пожизненно, но потомству не передаётся.

Условия заражения по письму:

- выезд в страны Африки, Центральной и Южной Америки;
- пребывание на транспортном средстве, следующем из этих регионов;
- погрузочно-разгрузочные работы в морских портах или аэропортах на транспорте, прибывшем из эндемичных стран, при наличии в трюмах и грузовых отсеках комаров-переносчиков.

Эпидемиологическая ситуация

За последний пятилетний период вспышки регистрировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Уганде, Гане, Республике Конго, Либерии, Центральноафриканской Республике, Эфиопии и Южном Судане; на территории Южной и Центральной Америки — в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Французской Гвиане, Перу и Суринаме, из которых наибольшее число заболевших — в Бразилии.

В 2023 году эпидемиологическое неблагополучие отмечено в 11 странах; наибольшее число случаев зарегистрировано в Чаде (2753), Нигерии (1819), Республике Конго (389) и ЦАР (349); случаи также выявлены в Гвинее, Габоне, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Южном Судане, Уганде и Сенегале. Полный список эндемичных стран дан приложением к письму.

Клиническая картина

Инкубационный период — до 6 суток. Течение разделяется на три периода: начальный (лихорадочный), ремиссия и период венозного стаза.

Период	Характеристика
Начальный	Острое начало: озноб, головная боль, боли в мышцах спины, поясницы и конечностей, температура 39–40 °C, позже тошнота и рвота. Одутловатость и гиперемия лица, шеи и верхней части туловища, инъекция сосудов склер и конъюнктив, отёчность век, ярко-красный язык; слезотечение, светобоязнь, бессонница, тахикардия, гепатоспленомегалия; больные эйфоричны и раздражительны
Ремиссия	На 4–5-е сутки температура снижается; ремиссия длится от нескольких часов до суток. При тяжёлом течении ремиссия может отсутствовать, а лихорадка длится 8–10 дней
Венозного стаза	Повторное повышение температуры, не достигающее первоначального уровня; желтушность кожи и слизистых; гиперемия лица сменяется бледностью с синеватым оттенком; кровоизлияния на слизистых, розеолёзно-петехиальная сыпь; брадикардия 40–50 в минуту, глухость тонов, гипотензия, коллапс; кровоточивость дёсен, носовые, маточные и желудочно-кишечные кровотечения, гематурия, олигоанурия; «амарильная маска» — одутловатое лицо с багрово-синюшным оттенком, блеск глаз, конъюнктивит, ярко-красные губы, светобоязнь и слезотечение. Пик — 6–8-е сутки с печёночно-почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью; с 8–9-х суток регресс и выздоровление

Амарильная маска

Название происходит от испанского *amarillo* — «жёлтый»: *fiebre amarilla* — испанское название жёлтой лихорадки, а прилагательное «амарильный» в медицинской литературе означает «относящийся к жёлтой лихорадке» (от того же корня — название вакцины «Стамарил»). Амарильной маской называют характерный вид лица больного: одутловатость, гиперемия лица и шеи с переходом в багрово-синюшный оттенок, инъекция сосудов склер и конъюнктивит, отёчность век, ярко-красные губы, блеск глаз, светобоязнь и слезотечение. При переходе в период венозного стаза на фоне маски проступает желтушность склер и кожи.

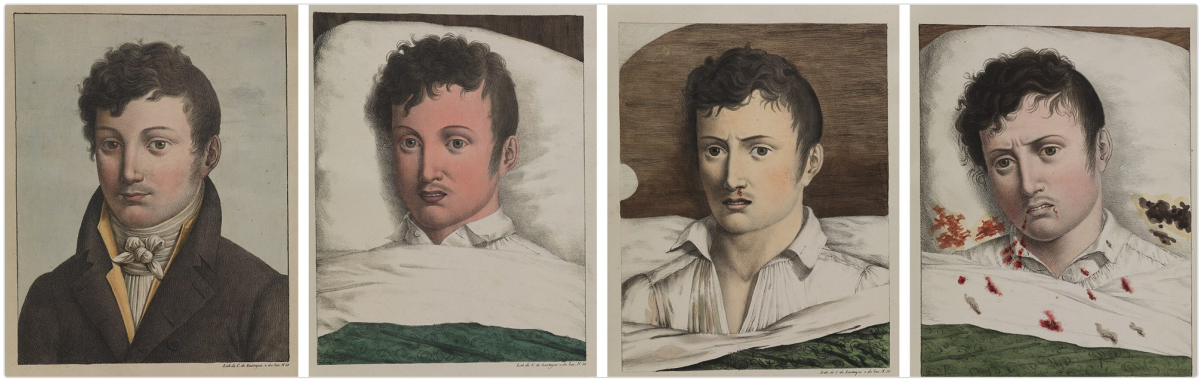


Рис. 1. Развитие жёлтой лихорадки в литографиях из «Observations sur la fièvre jaune, faites à Cadix, en 1819» (Pariset, Mazet, 1820). Слева направо: тот же мужчина до болезни; начальный период — гиперемия и одутловатость лица, инъекция склер (амарильная маска); период венозного стаза — желтушность кожи и склер, носовое кровотечение; терминальная стадия — геморрагический синдром с кровавой «чёрной» рвотой. Wellcome Collection, CC BY 4.0.

Летальность при тяжёлом течении достигает 25 %. Осложнения — инфекционно-токсический шок и острая печёночно-почечная недостаточность; присоединение вторичной флоры даёт пневмонию, абсцесс почек и сепсис.

Тактика и профилактика

При подозрении на жёлтую лихорадку показана эвакуация в инфекционный стационар; помощь на догоспитальном этапе ведётся по Алгоритмам.

Вакцинация — единственное надёжное средство профилактики: защита формируется через 10 дней после прививки, однократная вакцинация даёт пожизненный иммунитет.

Что предписано бригаде и диспетчерской

Кому	Предписание
Единая городская диспетчерская	При оформлении вызова к пациенту с температурой до 40 °C, мышечной болью в спине и суставах, желтушностью склер, головной болью, тошнотой и рвотой уточнять пребывание в эндемичных по ЖЛ странах (приложение к письму) и вносить сведения в приложение к вызову
Выездной персонал	Сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов, прибывших из неблагополучных по жёлтой лихорадке стран
Заведующие и старшие врачи	При подозрении — соблюдение приказа № 2710 от 10.11.2023; доведение письма до персонала

Источники

- Информационное письмо ГБУЗ «ССиНМП им. А. С. Пучкова» ДЗМ № 1-14/820 от 04.03.2024 с приложением «Список стран, эндемичных по жёлтой лихорадке».
- Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.02.2024 № 02/2306-2024-32 «О профилактике жёлтой лихорадки».
- Приказ ССиНМП им. А. С. Пучкова № 2710 от 10.11.2023.
- Pariset E., Mazet A. Observations sur la fièvre jaune, faites à Cadix, en 1819. Paris, 1820 — литографии стадий болезни.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
`images/pariset_mazet_1820.jpg`	Лицо здорового мужчины и больного жёлтой лихорадкой на трёх стадиях	Wellcome Collection через Wikimedia Commons: «Development of yellow fever Wellcome L0074838, L0074837, L0074836, L0074835.jpg», CC BY 4.0; кадрирование и компоновка — проект

Выходные данные

Жёлтая лихорадка · версия 1.1 · октябрь 2026 · Серия «Крещение поворотом» · CC BY-NC-SA 4.0. Материал носит справочный характер и не заменяет действующие приказы и клинические рекомендации.

Нашли ошибку — напишите в «Обсуждениях» репозитория на GitHub.